

CAPÍTULO 13.17

Neumonía viral

PERFIL EUNACOM 1.04.1.025

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La faringoamigdalitis es uno de los motivos de consulta más frecuentes en atención primaria y urgencias. Sin embargo, el desafío para el EUNACOM no es solo diagnosticar una amigdalitis pultácea, sino realizar el diagnóstico diferencial preciso con cuadros sistémicos que presentan compromiso faríngeo, como la **Escarlatina**, la **Enfermedad de Kawasaki** y la **Mononucleosis Infecciosa**.

Faringoamigdalitis: ¿Viral o Bacteriana?

La distinción inicial debe basarse en la clínica y, de ser necesario, en escalas validadas como el **Score de Centor**.

Amigdalitis Viral

Se caracteriza por la presencia de **síntomas catarrales** acompañantes. - **Clínica:** Odinofagia, rinorrea, disfonía, tos, y a veces vesículas o aftas. - **Score de Centor:** Habitualmente 0-1 punto. - **Conducta:** Tratamiento sintomático (analgesia, hidratación). No requiere antibióticos.

Amigdalitis Bacteriana (Estreptocócica)

Causada principalmente por *Streptococcus pyogenes* (SGA). - **Clínica:** Fiebre alta, odinofagia intensa, adenopatías cervicales dolorosas, exudado amigdalino bilateral y **ausencia de tos**. - **Manejo según Score de Centor:** - **4-5 puntos:** Alta probabilidad bacteriana. Iniciar antibióticos. - **2-3 puntos:** Dudoso. Idealmente realizar Test Rápido de Strep o Cultivo. - **0-1 punto:** Probablemente viral.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Criterios de Centor (Modificados): 1. Fiebre (>38°C): +1 2. Ausencia de tos: +1 3. Adenopatías cervicales anteriores dolorosas: +1 4. Exudado o edema amigdalino: +1 5. Edad: - 3 a 14 años: +1 - 15 a 44 años: 0 - ≥ 45 años: -1

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En niños **menores de 3 años**, la amigdalitis bacteriana por SGA es extremadamente rara. Ante un niño pequeño con fiebre y exudado, lo más probable es una etiología viral, frecuentemente por **Adenovirus**.

Diagnóstico Diferencial de Faringitis con Exantema

Cuando el cuadro faríngeo se acompaña de un exantema (rash), el abanico diagnóstico se amplía a patologías de alta relevancia en el examen.

1. Escarlatina

Es una complicación no supurativa de la infección por *S. pyogenes* productor de **toxina eritrogénica**. - **Exantema característico:** Descrito como "piel de gallina" o papel de lija (micropapular). - **Líneas de Pastia:** Petequias lineales en pliegues (fosa antecubital, axilas). - **Triángulo de Filatov:** Palidez perioral (respeta el área alrededor de la boca y nariz), similar a lo que se ve en el **Lupus Eritematoso Sistémico**. - **Laboratorio:** Neutrofilia marcada. - **Tratamiento:** Igual que la amigdalitis pultácea. **Penicilina benzatina** (1.2 millones UI si pesa >30kg) o Amoxicilina por 10 días.

2. Enfermedad de Kawasaki

Es una vasculitis de medianos vasos que puede comprometer las arterias coronarias. - **Clínica clave:** - Ojo rojo (conjuntivitis no purulenta). - Boca roja (labios fisurados, lengua en fresa). - Edema o descamación de manos y pies. - Adenopatía cervical (generalmente única y >1.5 cm). - Exantema polimorfo. - **Conducta:** 1. Solicitar **Ecocardiograma** (buscar dilatación de coronarias). 2. Iniciar **Inmunoglobulina G endovenosa (IGIV)** (lo más importante para prevenir aneurismas). 3. Aspirina a dosis altas.

3. Mononucleosis Infecciosa

Causada habitualmente por el virus de Epstein-Barr (VEB). - **Tríada clásica:** Fiebre, faringitis (con exudado blanquecino/grisáceo) y linfadenopatías difusas. - **Laboratorio:** Linfocitosis con linfocitos atípicos. - **Exantema tras antibióticos:** Un signo clásico para el EUNACOM es la aparición de un **rash morbiliforme** (similar al sarampión) tras la administración accidental de **Amoxicilina** o Ampicilina (ocurre en

el 90% de los casos). - **Otros hallazgos:** Esplenomegalia, hepatomegalia e ictericia.

NOTA CLÍNICA

La esplenomegalia en la mononucleosis conlleva un riesgo de **rotura esplénica**. Se debe recomendar al paciente evitar deportes de contacto por al menos 3 a 4 semanas.

Resumen Comparativo para el EUNACOM

TABLA 13.17.1: PATOLOGÍA VS HALLAZGO FARÍNGEO				
PATOLOGÍA	HALLAZGO FARÍNGEO	CARACTERÍSTICAS DEL EXANTEMA	LABORATORIO SUGERENTE	TRATAMIENTO
Amigdalitis Bacteriana	Exudado pultáceo	Generalmente ausente	Leucocitosis / Neutrofilia	Penicilina Amoxicilina
Escarlatina	Exudado pultáceo	Piel de lija, Líneas de Pastia, Triángulo Filatov	Neutrofilia	Penicilina Amoxicilina
Kawasaki	Labios rojos/fisurados	Polimorfo, edema de manos/pies	Reactantes de fase aguda muy elevados	IGIV + Aspirina
Mononucleosis	Exudado grisáceo/blanco	Morbiliforme (gatillado por Amoxicilina)	Linfocitosis atípica	Sintomático

Perlas Clínicas Finales

- Si un paciente tiene **esplenomegalia e ictericia** asociadas a un cuadro faríngeo, piensa de inmediato en **Mononucleosis Infecciosa**.
- Ante un cuadro de faringitis que no mejora con antibióticos y desarrolla un rash generalizado, sospecha que el antibiótico fue el desencadenante de la reacción en una mononucleosis.
- El diagnóstico de **Kawasaki** es clínico, pero la urgencia es el tratamiento con inmunoglobulina para evitar secuelas cardíacas.
- En la **Escarlatina**, el tratamiento antibiótico no es para acortar el cuadro del exantema, sino para prevenir la **Fiebre Reumática**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundir el triángulo de Filatov (palidez perioral en Escarlatina) con el eritema malar del **Lupus Eritematoso Sistémico**. En la Escarlatina, el resto de la cara está intensamente eritematosa, resaltando la palidez alrededor de la boca.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 65 años, diabético, consulta al 4to día de un cuadro gripal con aparición de disnea progresiva y desaturación a 88%. La radiografía muestra infiltrado intersticial bilateral. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Neumonía viral. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- COVID-19 e influenza son las causas más importantes de neumonía viral
- VRS, adenovirus y metaneumovirus son frecuentes en menores de 1 año; varicela se complica en embarazadas e inmunodeprimidos
- Inicia como infección respiratoria alta que evoluciona con disnea a los 3-4 días; si aparece después, sospechar sobreinfección bacteriana
- Radiografía: patrón intersticial bilateral; TAC de COVID-19: patrón multifocal en empedrado/vidrio esmerilado
- Hemograma: linfocitosis es el hallazgo habitual en neumonías virales
- Soporte respiratorio escalonado: naricera, mascarilla, cánula de alto flujo, VM no invasiva, VM invasiva, ECMO
- Influenza: oseltamivir EV; Varicela: aciclovir EV; COVID-19: dexametasona + heparina + eventual remdesivir
- La hipoxemia feliz (happy hypoxemia) se maneja con prono, no se intuba si el paciente está clínicamente bien
- Se recomienda cobertura antibiótica empírica por riesgo de sobreinfección bacteriana
- Aislamiento respiratorio es necesario para todos los pacientes hospitalizados con neumonía viral

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NEUMONÍA VIRAL)**PREGUNTA 1**

Paciente de 65 años, diabético, consulta al 4to día de un cuadro gripal con aparición de disnea progresiva y desaturación a 88%. La radiografía muestra infiltrado intersticial bilateral. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A)** Iniciar amoxicilina oral y control ambulatorio
- B)** Hospitalizar, iniciar soporte respiratorio, solicitar PCR/panel viral y cobertura antibiótica empírica
- C)** Iniciar oseltamivir oral ambulatorio
- D)** Solicitar TAC de tórax antes de decidir hospitalización
- E)** Iniciar dexametasona oral y control en 48 horas

PREGUNTA 2

Respecto al manejo de la neumonía por COVID-19 grave, ¿cuál de los siguientes tratamientos ha demostrado mayor impacto en el pronóstico?

- A)** Remdesivir endovenoso
- B)** Anticuerpos monoclonales
- C)** Dexametasona endovenosa
- D)** Ivermectina oral
- E)** Azitromicina oral

PREGUNTA 3

Paciente hospitalizado por neumonía viral por influenza, al día 10 de hospitalización presenta nueva alza febril, leucocitosis con desviación izquierda y nuevo infiltrado focal en radiografía. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Aumentar dosis de oseltamivir
- B)** Iniciar cobertura antibiótica para neumonía intrahospitalaria
- C)** Solicitar nueva PCR para influenza
- D)** Suspender oseltamivir y observar evolución
- E)** Iniciar corticoides sistémicos

RESUMEN: NEUMONÍA VIRAL

Las neumonías virales (neumonitis virales) tienen como causas más importantes la COVID-19 y la influenza. Otros virus como el VRS, adenovirus y metaneumovirus son frecuentes en menores de un año. La varicela puede complicarse con neumonía viral especialmente en embarazadas e inmunodeprimidos. A diferencia de las infecciones respiratorias altas, en la neumonía viral se solicita panel viral o PCR para identificar el agente, ya que esto determina el tratamiento antiviral. La presentación clínica inicia como infección respiratoria alta que a los pocos días (3-4 días) evoluciona con disnea y dificultad respiratoria. Si los síntomas respiratorios bajos aparecen muchos días después, se sospecha sobreinfección bacteriana. El examen pulmonar muestra crepitaciones bilaterales y la radiografía un patrón intersticial bilateral. En COVID-19 el TAC muestra un patrón multifocal en empedrado o vidrio esmerilado con parches alternados con zonas limpias. El hemograma habitualmente muestra linfocitosis. El manejo se basa en soporte respiratorio escalonado: oxígeno por naricera, mascarilla de alto flujo, cánula nasal de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica invasiva y ECMO como última línea. Para influenza se usa oseltamivir endovenoso, para varicela aciclovir endovenoso, y para COVID-19 se agregan dexametasona, heparina de bajo peso molecular y eventualmente remdesivir o anticuerpos monoclonales. Se recomienda cobertura antibiótica empírica por el alto riesgo de sobreinfección bacteriana. La posición en prono mejora la oxigenación en COVID-19.